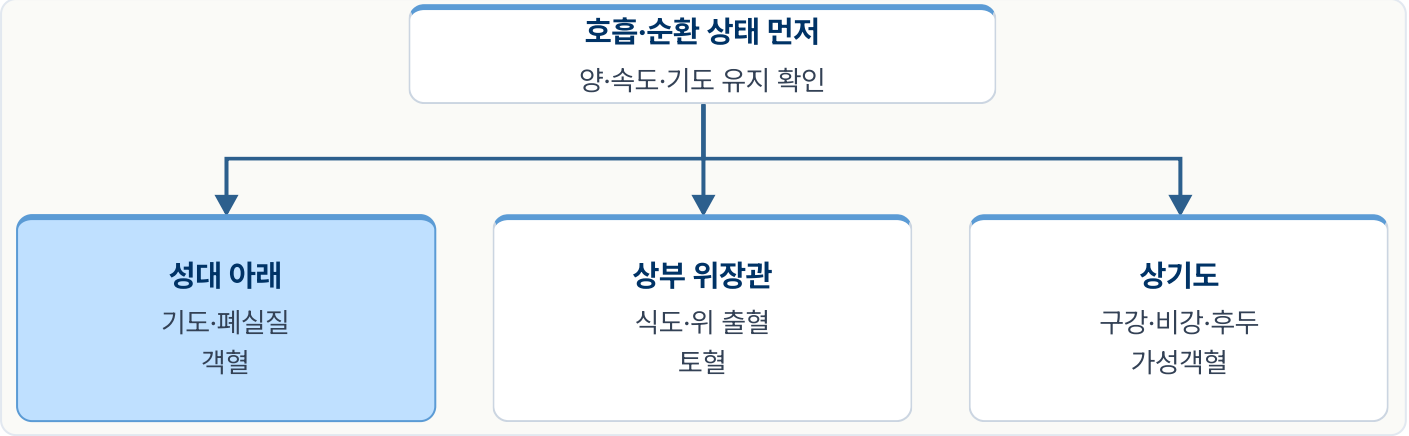
의료진 진료 카드 · ASL-067

입으로 나온 피 · 출혈원 감별

객혈은 성대 아래 기도·폐실질에서 나온 출혈이다. 먼저 환자 상태를 보고 출혈원의 단서를 모은다.

'입으로 피가 나왔다'에서 세 출혈원으로



전형적 출혈 양상 · 본강의

객혈	밝은 붉은색·거품, 상대적으로 알칼리성 pH. 기도에서 나와 공기와 섞이는 특징. 기침·호흡곤란·흉통, 빈혈은 상대적으로 드묾.
상부위장관 출혈	커피찌꺼기 같은 갈색·검은색, 음식물 혼합, 산성 pH. 복통·오심·구토·흑색변, 빈혈이 상대적으로 흔함.
상기도 출혈	밝은 붉은색, 주로 거품 없음. 구강·비강·후두의 출혈 흔적과 코피·잇몸출혈·치은염·모세혈관확장·궤양·정맥류 등의 단서.

출혈원 평가와 위험 신호

문진·진찰	환자가 '객혈'이라 말해도 코·구강·위장관 출혈을 감별. 발현 전 기침·구토와 코피, 동반 흑색변, 구강·비강 출혈 흔적을 함께 확인.
소량도 위험	기도를 막으면 작은 양도 호흡부전·혈역학 불안정 가능. 호흡곤란·호흡수 증가·노력호흡·천명·청색증·저산소증·의식변화, 저혈압·빈맥을 본다.
순서	비중증은 초기 평가, 생명위협 객혈은 환자 안정화 후 평가. 출혈량만이 아니라 출혈속도·환자 예비능·기도 유지가 중요.

색·거품·동반 증상은 출혈원을 찾는 단서다. 강의는 정확한 출혈량 평가의 어려움과 면밀한 병력·검사를 강조했다. 비위관 흡인액의 피는 비교표의 위장관 출혈 소견으로 읽고 일률적 세척 절차로 만들지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-067

객혈 · 초기 평가와 연결

출혈원을 구분한 뒤 위치와 원인을 평가한다. 비중증이라도 24~48시간에 다시 본다.

본강의 · 병력과 기본 검사

병력	흡연력, 심장·간·신장질환, 발열·체중감소·기침·가래, 혈소판 감소, 가족·다른 부위 출혈력, 항응고제·항혈소판제, 혈전력·위험요인.
기본 검사	활력징후에 산소포화도 포함. CBC로 빈혈·백혈구·혈소판 평가; 간·신기능과 PT/aPTT. ABGA·혈액형·배양·염증표지자·IGRA·심장검사·자가항체·객담세포검사는 의심 원인에 따라 선택.
영상·내시경	흉부 X-ray → 조영 CT/CT angiography·기관지내시경을 원인·위치에 맞춰 고려. CXR 출혈 위치 확인 약 46%, CT와 내시경은 상호 보완.

중증도와 전원 · 본강의

양·속도 단서	24시간 ≥150mL, 시간당 ≥100mL를 대량 객혈 판단 기준으로 설명. 소주잔 약 50mL에 비유해 하루 3잔·1시간 2잔을 문진 예로 제시. 수치에 도달할 때까지 기다리지 않는다.
생명위협	사망은 출혈성 쇼크보다 기도 내 혈액에 의한 질식과 관련. 출혈 쪽을 아래로 옆눕히는 lateralization, 기도·혈역학 안정화 후 빠른 전원; 필요 시 기관삽관을 고려.
비중증	진해제+원인 치료, 응고장애·항혈전제 확인. 24~48시간 내 재평가, 지속하거나 원인이 불명확하면 검사 가능한 병원으로 의뢰. 반복 객혈은 암 등 적극적 원인 평가.

진료실에서 놓치지 않을 축

호흡·순환

양이 적어도 저산소·의식변화·저혈압이 있으면 안정화와 전원을 우선한다.

원인·재평가

기관지염이 흔해도 기관지확장증·결핵·암을 감별하며, 처음 치료 후 짧은 간격에 다시 본다.